

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CONCURSO-OPOSICIÓN 2023 PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE:
MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA – PRUEBA APLAZADA

ADVERTENCIAS:

- **ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con TELEFONO MÓVIL (o dispositivo electrónico conectado a datos, en general).**
- **EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL TELEFONO MÓVIL ANTES DE ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.**
- **ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.**
- **NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.**
- **EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.**

- Compruebe que en su «**Hoja de Respuestas**» están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla.**
- **El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.**
- **Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto cuando se indique.**
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. PARA ELLO LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «**1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO**» y «**2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO**».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba teórica deben ser contestadas en la «**Hoja de Respuestas**», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «**Reserva**» de la «**Hoja de Respuestas**», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor y sumarían un máximo de 50 puntos.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba práctica deben ser contestadas en la «**Hoja de Respuestas**», numerada de la 101 a la 150.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor y sumarían un máximo de 50 puntos.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «**Hoja de Respuestas**».
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «**Hoja de Respuestas**» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
- Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUADERNILLO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO. Si desea un ejemplar puede obtenerlo en la página web del Organismo.

**CONTINÚA EN LA
CONTRAPORTADA**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

**SAS_MÉDICO/A DE FAMILIA EN
UNIDADES DE URGENCIA
HOSPITALARIA 2023 / TURNO
LIBRE / PRUEBA APLAZADA**

**CUESTIONARIO
TEÓRICO**

-
- 1 La Constitución Española señala que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, en su artículo:**
- A) 50.
 - B) 51.
 - C) 52.
 - D) 53.
- 2 La Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma, y está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. Además, el Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) establece que otras instituciones y órganos regulados en el mismo texto legal forman parte también de la organización de la Junta de Andalucía, y entre estos se encuentra:**
- A) Defensor del Pueblo Andaluz.
 - B) Consejo de Transparencia.
 - C) Cámara de Comercio de Andalucía.
 - D) Consejo de Radiotelevisión Pública de Andalucía.
- 3 Los pinchazos accidentales constituyen un importante problema de salud laboral por su relativa alta frecuencia (son el accidente con riesgo biológico más corriente) y por las consecuencias que pueden comportar desde el punto de vista de contagio. Todas las siguientes son recomendaciones básicas que deben seguirse para evitar accidentes de este tipo, EXCEPTO:**
- A) Desechar las pipetas de vidrio con el borde roto.
 - B) No manipular residuos en el interior de los contenedores, ya que estos pueden contener en su interior agujas y material punzante o cortante.
 - C) No volver a encapsular las agujas ya usadas.
 - D) Usar guantes desechables para cualquier manipulación de material sanitario.

- 4 **El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ley 55/2003), señala en su artículo 10, como principal instrumento de configuración y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), y que conocerá, debatirá y, en su caso, emitirá recomendaciones sobre los criterios para la coordinación de la política de recursos humanos del SNS:**
- A) A la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
 - B) Al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
 - C) Al Ministerio de Sanidad.
 - D) Al Foro Marco para el Diálogo Social.
- 5 **Referido a la obtención por primera vez de la Tarjeta Sanitaria de Andalucía, todas las siguientes afirmaciones son ciertas, EXCEPTO:**
- A) Supone el registro del solicitante en la Base de Datos de personas usuarias (BDU).
 - B) Al solicitar la tarjeta es imprescindible que el/la ciudadano/a señale el centro de atención primaria y profesional de medicina de familia o pediatría que desea.
 - C) Requiere la acreditación de la residencia en Andalucía mediante certificado de empadronamiento.
 - D) Es necesario presentar el modelo de solicitud, cumplimentado, en un centro de atención primaria.
- 6 **Los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) están asegurados mediante un contrato de seguro de responsabilidad que garantiza las consecuencias económicas a las que vendría obligado a indemnizar por haber causado daños y perjuicios a un tercero en la actividad prestada para el SAS. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre esta cobertura es cierta?**
- A) Si un profesional del SAS es considerado responsable por cualquier actuación amparada por el contrato de seguro de responsabilidad, que no sea causada por una intención de producir voluntariamente un daño a un tercero, no tendrá que abonar cantidad alguna.
 - B) Los profesionales del SAS están siempre asegurados, ya que ante cualquier situación, tanto la responsabilidad civil profesional como la responsabilidad patrimonial está cubierta por la empresa de seguros que tenga contratada el Organismo.
 - C) En caso de recibir una reclamación, hay que comunicar la misma directamente al Servicio de Gerencia de Riesgos del SAS.
 - D) Todos los profesionales del SAS cuentan con la defensa de los letrados del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no está previsto que el profesional elija a su propio abogado.
- 7 **Referido a los indicadores de salud, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
- A) Un indicador puede ser algo tan simple como un número absoluto de eventos, o un cálculo complejo, como la esperanza de vida al nacer o la tasa de fecundidad.
 - B) Los indicadores de salud deben ser mediciones relativas, que están compuestos por un numerador y un denominador que, por lo general, se refieren al mismo período y el mismo lugar.
 - C) Son mediciones absolutas: la razón, la proporción, la tasa y los llamados odds.
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

- 8 La tasa de fecundidad es un buen indicador de la conducta reproductiva de la población, que además no se ve afectado por la estructura etaria. ¿Cómo se calcula?**
- A) Numero de nacidos vivos en un año / número de mujeres a mitad de ese año.
 - B) Número de embarazos en un año / número de mujeres entre 15 y 49 años a mitad de ese año.
 - C) Número de nacidos vivos en un año / número de mujeres entre 15 y 49 años a mitad de ese año.
 - D) Promedio de hijos que cada mujer dejaría al cumplir los 50 años.
- 9 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la desviación estándar es correcta?**
- A) La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica cuán dispersos están los datos con respecto a la media.
 - B) En una muestra de valores, mientras mayor sea la desviación estándar de una variable, menor será la dispersión de los datos de dicha variable.
 - C) El símbolo σ (sigma) se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una muestra.
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 10 Usted está llevando a cabo un análisis de la casuística de su unidad en el último año, con los datos que le han proporcionado desde el Servicio de Información y Calidad, y quiere comprobar si la mortalidad hospitalaria está relacionada con los días de la semana. En concreto, teniendo datos de los pacientes hospitalizados y de los éxitos habidos durante el ingreso hospitalario, así como de la fecha y hora de fallecimiento en cada caso, se plantea responder a la siguiente pregunta operativa: ¿es diferente la proporción de mortalidad (razón de N° de pacientes fallecidos/N° de pacientes ingresados) si se comparan fines de semana (desde las 00 horas del sábado hasta las 8 horas del lunes) con resto de los días de la semana (desde las 8.01 horas del lunes a las 23.59 horas del viernes)?. Para llevar a cabo esta comparación entre las dos variables así definidas, recurrirá a ¿qué test de contraste de hipótesis?**
- A) Test T de Student.
 - B) Test Chi cuadrado.
 - C) Regresión lineal simple.
 - D) Regresión logística multivariante.
- 11 ¿Qué prueba de las siguientes emplearía para evaluar una posible asociación o relación entre dos variables cuantitativas?**
- A) T de Student.
 - B) Chi cuadrado.
 - C) Regresión lineal simple.
 - D) ANOVA.

- 12 Plantea hacer un estudio de investigación sobre una de las patologías que con más frecuencia se atiende en las consultas generales de su unidad clínica, partiendo de la premisa de que "seguro que dispondrá de una muestra grande en la que podrá hacer múltiples análisis y comparaciones". Al final, después de un trabajo recopilatorio que le ha supuesto un gran esfuerzo a usted y a sus residentes, ha conseguido identificar a 364 pacientes que cumplirían con el diagnóstico de la patología concreta que pretenden analizar, y ahora se disponen a recoger múltiples variables demográficas, clínicas y evolutivas (en total 74 variables) en una Hoja de Recogida de Datos que ha diseñado para ello. Sobre este estudio de investigación y su diseño, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
- A) Es un estudio que, aunque no demasiado bien planificado, tiene un diseño de cohorte retrospectiva, y se podrán hacer análisis de factores etiológicos y pronósticos de la enfermedad en cuestión.
 - B) Como se conoce qué pacientes de la muestra han fallecido, se hará un diseño de casos y controles para evaluar los factores relacionados con la mortalidad en esta enfermedad.
 - C) En principio es un diseño de tipo descriptivo, y cualquier comparación entre variables recogidas en esta serie de pacientes debe, además de minimizarse, tener sentido a la luz de los conocimientos actualizados en dicha enfermedad y someterse a la máxima prudencia a la hora de sacar conclusiones.
 - D) Por la cantidad de variables recogidas, seguro que habrá de recurrirse a los análisis multivariantes al hacer comparaciones estadísticas.
- 13 Está evaluando un brote epidémico con 60 afectados (vómitos y diarreas), y tiene datos de las 300 personas que estuvieron a riesgo, pues fue una celebración a puerta cerrada en un restaurante. De 70 personas que recuerdan haber tomado unas tartaletas con ensaladilla, 50 tienen síntomas de gastroenteritis aguda (GEA); mientras que en los restantes 230 invitados, que no tomaron dichos canapés (o no lo recuerdan bien) hay 10 con GEA. Con estos datos se pueden calcular diferentes indicadores; pero, ¿cuál de los siguientes es la odds ratio de GEA asociada al consumo de tartaletas de ensaladilla?**
- A) $OR = (50 \times 220) / (10 \times 20) = 55$.
 - B) $OR = 50 / 10 = 5$.
 - C) $OR = (50 / 70) / (10 / 230) = 16.4$.
 - D) Ninguno de los anteriores.
- 14 En la metodología de diseño de los PAIs (Procesos Asistenciales Integrados), ¿qué es cierto referido al "límite final"?**
- A) La salida del proceso puede producirse en cualquiera de los niveles asistenciales.
 - B) En los procesos crónicos, el límite final es siempre el fallecimiento del paciente.
 - C) En los procesos agudos, suele ser difícil establecer con precisión el límite final.
 - D) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

- 15 La precisión de las pruebas diagnósticas se define en relación con un "método ideal" (o gold estándar) aceptado, que define el presunto estado real del paciente, y la exactitud de la nueva prueba para distinguir entre la enfermedad y la salud se determina en relación con los resultados del estándar de referencia y se resume en cuatro estimaciones. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, sobre estas estimaciones, es INCORRECTA?**
- A) La sensibilidad -o tasa de resultados positivos verdaderos de una nueva prueba- es la proporción de pacientes con la enfermedad (definida por el gold estándar) que tienen un resultado positivo en la nueva prueba.
 - B) La proporción de pacientes con enfermedad que tienen una prueba negativa, es la tasa de resultados negativos falsos, que se calcula como $(1 - \text{especificidad})$.
 - C) Entre los pacientes sin enfermedad, la proporción de casos con pruebas negativas corresponde a la especificidad, o tasa de resultados negativos verdaderos.
 - D) La especificidad, o tasa de negativos verdaderos, refleja qué tan bien la prueba nueva identifica en forma correcta a los pacientes sin la enfermedad.
- 16 El manejo inicial en urgencias de un paciente hemodinámicamente estable, con taquicardia regular de complejo QRS estrecho, puede incluir:**
- A) Maniobras vagales.
 - B) Adenosina.
 - C) Verapamilo.
 - D) Todas las anteriores.
- 17 Dentro de las manifestaciones agudas de las malformaciones cardíacas y su tratamiento, ¿cuál de las siguientes es la FALSA?:**
- A) El riesgo de endocarditis infecciosa (EI) de los pacientes con cardiopatía congénita del adulto es menor que para la población general.
 - B) La insuficiencia cardíaca es una complicación frecuente que afecta al 20-50% de los pacientes con cardiopatía congénita y es su principal causa de muerte.
 - C) El trasplante cardiopulmonar se aplica a pacientes con cardiopatía congénita que tengan hipertensión arterial pulmonar irreversible, como el síndrome de Eisenmenger.
 - D) Después de evaluar la causa del episodio y excluir las causas reversibles, está indicado el implante de un DAI para los adultos con cardiopatía congénita que han sobrevivido a parada cardíaca por FV o TV no tolerada hemodinámicamente.
- 18 En relación al diagnóstico de pancreatitis aguda mediante pruebas de laboratorio, ¿cuál es la respuesta FALSA?**
- A) La lipasa es la prueba de diagnóstico preferida, ya que es más precisa.
 - B) La amilasa sérica normal excluye el diagnóstico de pancreatitis aguda.
 - C) Niveles de lipasa o amilasa de, al menos, dos o tres veces el límite superior del normal, apoyan el diagnóstico de pancreatitis aguda.
 - D) Hay muchas fuentes de amilasa extrapancreática, por lo que es relativamente inespecífica.

- 19 Paciente de 30 años que sufre atropello por automóvil mientras circula en bicicleta. En la atención inicial en el área de críticos presenta frecuencia cardíaca 115 latidos por minuto y presión arterial 110/75 mmHg con relleno capilar de 2,5 segundos. Con estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones considera que es la correcta?**
- A) Se ha producido una pérdida de más del 50% de la volemia, y precisa reposición de volumen y sangre.
 - B) Se ha producido una pérdida entre un 15 y un 30% de la volemia, y precisa reposición de volumen.
 - C) Se ha producido una pérdida del 40% de la volemia, y requiere tratamiento quirúrgico.
 - D) Se ha producido una pérdida del 30% de la volemia, y precisa reposición de volumen y sangre.
- 20 En la atención inicial a un paciente que acaba de sufrir un accidente de tráfico, lo encontramos consciente y, en toma de constantes, presenta una presión arterial sistólica de 70 mmHg y una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto. Además, la piel de las extremidades está caliente. ¿Cuál es la causa más probable de shock?**
- A) Shock hipovolémico.
 - B) Shock cardiogénico.
 - C) Shock neurogénico.
 - D) Shock séptico.
- 21 En los pacientes con diagnóstico de Síndrome de Marfan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?**
- A) Los bloqueadores beta están contraindicados en los pacientes con síndrome de Marfan.
 - B) El riesgo de disección tipo A aumenta claramente cuando el diámetro de la raíz aórtica es mayor o igual a 50 mm.
 - C) La hipertensión arterial en reposo o durante el ejercicio es común, incluso después del éxito del tratamiento.
 - D) La cirugía profiláctica de la raíz aórtica es el único tratamiento definitivo para prevenir la disección aórtica en el síndrome de Marfan.
- 22 En la realización de un tacto rectal se objetiva la presencia de prolapso hemorroidal por el orificio anal, de aparición con la defecación, y que requiere reducción manual. ¿Qué grado de prolapso acabamos de definir?**
- A) Grado I.
 - B) Grado II.
 - C) Grado III.
 - D) Grado IV.

23 Con respecto a la patología anorrectal urgente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) Factores como el tabaquismo, el coito anal, el VIH y las verrugas genitales están asociados con el cáncer anorrectal.
- B) Las micosis son la causa más frecuente de prurito anal en los niños.
- C) Los objetos grandes en recto pueden crear un efecto parecido al vacío, lo que imposibilita la extracción por simple tracción. En estos casos, el vacío puede superarse pasando un catéter alrededor del cuerpo extraño e inyectando aire en la ampolla.
- D) En los adultos con prolapso rectal, la reducción puede ser más difícil si las paredes rectales se han vuelto edematosas. Cantidades generosas de azúcar granulada, aplicadas 15 minutos con una presión continua y directa antes de la reducción, pueden ayudar en el proceso.

24 De las siguientes afirmaciones con respecto a las técnicas diagnósticas en urgencias y emergencias, señale la verdadera:

- A) En los niños menores de 6 años, el sitio de punción del acceso venoso intraóseo se localiza 2-3 cm por encima del maléolo tibial interno.
- B) En el acceso de la vena femoral, para su localización, debemos recordar que la distribución del paquete vasculonervioso femoral es de fuera a dentro, como sigue: vena, arteria y nervio femoral.
- C) En la desfibrilación es imprescindible pulsar el botón de sincronizado para que la descarga coincida con la onda R.
- D) La realización de la punción lumbar no debe nunca retrasar el tratamiento antibiótico en un paciente con sospecha de meningitis.

25 En el manejo de un paciente en shock séptico, ¿cuál de las siguientes medidas se debe emplear en las primeras tres horas?

- A) Se recomienda extraer hemocultivos antes de administrar antibioterapia empírica, siempre que no se retrase el inicio de la administración de antibiótico.
- B) Se recomienda administrar 30 ml/kg de cristaloides si hipotensión o shock séptico.
- C) Medir el nivel de lactato.
- D) Todas las anteriores son correctas.

26 En el tratamiento de las hemorroides externas trombosadas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A) Si la trombosis ha estado presente durante < 48 h y es en extremo dolorosa, se puede tratar al paciente con baños de asiento y laxantes formadores de masa.
- B) Si la trombosis ha persistido por > 48 h, se puede lograr alivio importante con la escisión del coágulo.
- C) No se debe llevar a cabo la escisión, en el servicio de urgencias, en pacientes inmunodeprimidos, niños, mujeres embarazadas, pacientes con hipertensión portal ni en los que reciben tratamiento anticoagulante o tienen una coagulopatía.
- D) Las respuestas A) y B) son correctas.

- 27 Un niño de seis años que camina por la calle es golpeado por el parachoques delantero de un vehículo que se desplaza a 40 kilómetros por hora. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?**
- A) Lo más probable es que el niño tenga una contusión miocárdica.
 - B) Es posible que tenga una contusión pulmonar en ausencia de fracturas.
 - C) La sección de la aorta torácica es más probable que en un paciente adulto.
 - D) Las fracturas costales son comunes en los niños con este mecanismo de trauma.
- 28 En el manejo del neumotórax abierto, el primer paso a realizar es:**
- A) Intubación orotraqueal.
 - B) Colocar un tubo de drenaje pleural en el hemitórax afectado, a través de la herida.
 - C) La herida abierta debe cubrirse con un parche de sellado de tórax con válvula unidireccional; si no se dispone de éste, se utiliza un vendaje vaselinado abierto por una de sus puntas.
 - D) Realizar radiografía de tórax para confirmar la presencia de neumotórax a tensión.
- 29 Dentro de las medidas de reanimación circulatoria en los pacientes con traumatismo grave, ¿cuál de las siguientes afirmaciones considera que NO es correcta?**
- A) En pacientes con TCE grave se deben emplear soluciones hipotónicas como Ringer-lactato, que ayudan a controlar el edema cerebral.
 - B) Se debe restringir el uso de coloides debido a sus efectos adversos sobre la hemostasia.
 - C) Se recomienda iniciar fluidoterapia con cristaloides isotónicos en el paciente hipotenso por sangrado postraumático.
 - D) Se deben evitar las soluciones salinas isotónicas, como las disponibles de NaCl 0,9%, en cantidad superior a 1,5 litros.
- 30 ¿Cuál de los siguientes NO se encuentra entre los factores de riesgo para posible intubación difícil?**
- A) Test de Mallampati 2.
 - B) Apertura bucal menor de 3 cm.
 - C) Obesidad > 20% del peso ideal.
 - D) Distancia tiromentoniana menor de 3 traveses de dedo.

31 Con respecto a los criterios transfusionales en pacientes con evidencia de hemorragia aguda gastrointestinal alta no varicosa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera?

- A) En pacientes jóvenes, sin patología de base, hemodinámicamente estables y sin evidencia de sangrado activo, se puede mantener conducta expectante con cifras de hemoglobina inferiores a 7 g/dl, si la anemia se tolera bien.
- B) En pacientes con patología cardiovascular y/o hemorragia activa no se recomienda transfusión si la Hb está por debajo de 8 g/dl.
- C) En pacientes estables sin patología cardiovascular ni hemorragia activa, con hemoglobina $\geq$ 10 g/dl se recomienda transfusión para mantener la hemoglobina superior a 12 g/dl.
- D) En pacientes con evidencia de hemorragia grave y shock, el hematocrito es el indicador principal del grado de pérdida hemática.

32 En relación con el manejo inicial de la pancreatitis aguda, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) La reanimación con líquidos se asocia a una reducción de mortalidad y a una menor incidencia de complicaciones.
- B) El valor de las enzimas pancreáticas es un parámetro útil para predecir severidad, definir pronóstico y establecer el momento adecuado para reiniciar la alimentación.
- C) La TAC abdominal es una técnica de mayor sensibilidad y especificidad que la ecografía; no obstante, es más útil en las primeras 48-72 horas de evolución que al ingreso.
- D) No se recomienda el uso de profilaxis antibiótica en la pancreatitis aguda, ni siquiera en la pancreatitis aguda necrosante.

33 En las infecciones intraabdominales, señale la FALSA:

- A) En cirróticos, la mayor parte de las PBE (peritonitis bacteriana espontánea) se deben a anaerobios.
- B) Los patógenos clave son las enterobacterias.
- C) La neutropenia y el tratamiento antibiótico previo son factores de riesgo para infección por *Pseudomona*.
- D) Una infección intraabdominal leve-moderada sin factores de riesgo de mala evolución podría tratarse con cefalosporinas de 3ª generación + Metronidazol.

34 En las infecciones del tracto urinario, es cierto que:

- A) Trataremos empíricamente con Ciprofloxacino si no hay datos de gravedad.
- B) En la prostatitis aguda, si sospechamos microorganismo BLEE, podremos usar de forma empírica Ertapenem 1 gramo cada 24 horas por vía intravenosa.
- C) En cistitis aguda complicada, el tratamiento de primera elección es Fosfomicina-trometamol 3 g en dosis única.
- D) Sólo es preciso toma de urocultivo en caso de ingreso.

- 35 Respecto a la infección, tratamiento y profilaxis de la infección por SARS-CoV-2, es correcta:**
- A) La posología habitual de Dexametasona oral en neumonía por COVID-19 es de 6 mg cada 24 horas durante 10 días.
 - B) A un paciente con infección por COVID-19 confirmada, tos y saturación del 96% (sin O2 suplementario) se le debe realizar gasometría arterial.
 - C) A los pacientes con infección COVID-19 que tengan antecedentes de hipercoagulabilidad o Dímero D elevado en el momento de la evaluación, se les indicará anticoagulantes de acción directa.
 - D) Un TAC craneal sin hallazgos patológicos descarta trombosis de senos venosos como complicación de la vacunación COVID-19.
- 36 Uno de los siguientes fármacos NO está indicado en el tratamiento de pacientes con infección por SARS-CoV-2:**
- A) Dexametasona.
 - B) Hidroxicloroquina.
 - C) Sotrovimab.
 - D) Tocilizumab.
- 37 En la malaria, ¿cuál de los siguientes enunciados es FALSO?**
- A) Se debe sospechar paludismo en pacientes con cualquier enfermedad febril si han estado expuestos a una región donde el paludismo es endémico.
 - B) No presenta manifestaciones en Sistema Nervioso Central.
 - C) La esplenomegalia es un hallazgo frecuente en la exploración.
 - D) La evaluación de laboratorio puede demostrar parasitemia, anemia, trombocitopenia, transaminasas elevadas, coagulopatía leve y nitrógeno ureico en sangre (BUN) y creatinina elevados.
- 38 En un síndrome febril sin foco, en paciente no inmunocomprometido, es FALSO:**
- A) Consideraremos la fiebre de larga evolución si es superior a los 21 días.
 - B) La acidosis metabólica es un criterio de gravedad.
 - C) Realizaremos en Urgencias toma de muestra de hemocultivo solo si el paciente presenta fiebre.
 - D) Planteamos la endocarditis como sospecha diagnóstica ante fiebre sin foco y un soplo de nueva aparición.
- 39 En la elección del tratamiento antibiótico empírico, debemos considerar todas las siguientes circunstancias, EXCEPTO:**
- A) La relación del paciente con el medio sanitario.
 - B) Las tasas locales de enterobacterias productoras de β -lactamasas de espectro extendido (BLEE).
 - C) Cronas al centro útil, por si la evolución no fuera adecuada y se precisara activar código sepsis.
 - D) Los resultados microbiológicos previos recientes.

40 NO se considera en Urgencias una condición indicadora de infección por VIH:

- A) Neumonía Adquirida en la Comunidad en pacientes entre 18 y 65 años.
- B) Síndrome mononucleósico.
- C) Trombocitopenia idiopática de 2 semanas de evolución.
- D) Infección por herpes zóster.

41 Respecto a la fiebre en las infecciones importadas y enfermedades infecciosas emergentes, indique qué respuesta es FALSA:

- A) La malaria suele presentar fiebre “en agujas”, aunque en el momento del diagnóstico puede no tener fiebre.
- B) La fiebre “en joroba” o bifásica suele orientar a Dengue y otras virasis hemorrágicas.
- C) En la fase virémica (primera semana) del Chikungunya, la fiebre suele ser baja (o ausente).
- D) En la viruela del mono (Monkeypox), las manifestaciones cutáneas suelen aparecer típicamente de 1 a 5 días después de la fiebre.

42 ¿Cuál de los siguientes parámetros puntúa en la escala SOFA?

- A) INR (Tiempo de Protrombina Normalizado).
- B) Frecuencia respiratoria.
- C) Recuento de plaquetas.
- D) TTPA (Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado).

43 Respecto a la viruela del mono (Monkeypox), diga cuál es la respuesta FALSA:

- A) Las personas que han recibido la vacuna contra la viruela, incluso 25 años atrás, tienen menor riesgo que los no vacunados de sufrir la viruela del mono.
- B) La mortalidad deriva fundamentalmente de la meningoencefalitis y de la sobreinfección bacteriana.
- C) Las lesiones dérmicas respetan palmas de las manos y plantas de los pies.
- D) Además de las lesiones cutáneas, el paciente puede referirnos cefalea, mialgias, fiebre y odinofagia.

44 En cuanto al tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, ¿cuál es la respuesta FALSA?

- A) El Nimatrelvir-Ritonavir (Paxlovid®) está indicado en pacientes con enfermedad leve o moderada (generalmente ambulatorios) y alto riesgo de progresión a formas graves.
- B) La dosis de Dexametasona en neumonías por SARS-CoV-2 es de 0,5 a 1 mg/kg/24 horas.
- C) En pacientes ingresados con datos de sobreinfección bacteriana por *Psuedomona*, podemos usar Cefepime o Piperazilina-Tazobactam.
- D) La fluidoterapia, en ausencia de shock, debe utilizarse de forma restrictiva adecuándola al estado de hidratación y comorbilidad del paciente.

45 ¿Cuál de estas infecciones de transmisión sexual NO presenta úlceras genitales?

- A) Sífilis.
- B) Gonorrea.
- C) Linfogranuloma venéreo.
- D) Herpes genital.

46 En cuanto a la endocarditis infecciosa, señale la respuesta FALSA:

- A) El agente etiológico más común de la endocarditis infecciosa en usuarios de drogas intravenosas es el *Staphylococcus aureus*.
- B) La terapia anticoagulante reduce el riesgo de embolia en pacientes con endocarditis infecciosa.
- C) La cirrosis hepática es un factor de riesgo no cardiológico para sufrir una endocarditis infecciosa.
- D) Se recomienda obtener al menos dos muestras de hemocultivos de venopunciones separados antes de iniciar la terapia con antibióticos.

47 En la otitis externa maligna, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Tiende a ser crónica.
- B) Predomina en pacientes diabéticos.
- C) La *Pseudomonas aeruginosa* es el germen más frecuentemente aislado.
- D) El tratamiento de elección es Amoxicilina-Clavulánico.

48 En la rinosinusitis maxilar aguda bacteriana, señale la respuesta correcta:

- A) Los síntomas se hacen patentes a partir del quinto día.
- B) El examen radiológico convencional de los senos está indicado para su diagnóstico.
- C) El tratamiento sintomático con descongestivos nasales está contraindicado.
- D) El tratamiento antimicrobiano de elección es Ciprofloxacino.

49 En el paciente con absceso periamigdalino, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Es más frecuente la localización anterosuperior y en adultos jóvenes.
- B) En la exploración se detecta abombamiento de la amígdala.
- C) El drenaje quirúrgico es la medida más importante.
- D) El tratamiento antimicrobiano de elección es Clindamicina.

50 En el tratamiento de la hipertensión intracraneal por traumatismo craneoencefálico, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Monitorización de la Presión intracraneal (PIC).
- B) Manitol.
- C) Furosemida.
- D) Dexametasona.

51 ¿En qué situación debe priorizarse la realización de la tomografía axial computarizada (TAC) frente a la radiografía simple de columna cervical, en el contexto de dolor cervical traumático?

- A) Dolor cervical en la línea media.
- B) Intoxicación etílica.
- C) Parestesias en miembros superiores.
- D) Todas las anteriores.

52 Respecto a los vómitos durante el embarazo, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Se presentan alrededor de la sexta semana.
- B) La obesidad es un factor de riesgo.
- C) Suelen ser más intensos por la tarde.
- D) Está indicado el tratamiento con Piridoxina (vitamina B6) oral.

53 En la paciente con herpes genital, señale la respuesta correcta:

- A) El herpes virus 1 es el causante de la mayoría de los casos.
- B) La clínica aparece entre 3 y 7 días después del contacto.
- C) Cura en 3 ó 4 semanas, generalmente con secuelas.
- D) Se recomienda la administración de Aciclovir tópico.

54 Respecto a la técnica de elección en el paciente estable con sospecha de traumatismo renal, señale la respuesta correcta:

- A) Radiografías tórax (postero-anterior y lateral) y Radiografía abdomen simple.
- B) Tomografía Axial computarizada abdominal sin contraste.
- C) Tomografía Axial computarizada abdominal con contraste.
- D) Ecografía renal.

55 Respecto a las recomendaciones al alta, tras un traumatismo craneoencefálico, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Reposo relativo durante 24-48 horas.
- B) Dieta absoluta durante las primeras 8 horas.
- C) No ingerir tranquilizantes.
- D) No ingerir analgésicos.

56 En la intoxicación aguda por cianuro, señale la respuesta correcta:

- A) Origina alcalosis metabólica.
- B) Ocasiona cianosis.
- C) Los síntomas se inician a partir de los 60 minutos, después de la inhalación.
- D) La Hidroxicobalamina (vitamina B12) es el tratamiento de elección.

57 En la intoxicación aguda por cocaína, señale la correlación INCORRECTA:

- A) Convulsión – Midazolam.
- B) Psicosis tóxica – Olanzapina.
- C) Hipertensión arterial – Atenolol.
- D) Taquicardia supraventricular – Verapamilo.

58 En el paciente oncológico con síndrome de la vena cava superior, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Se caracteriza por edema facial y en los miembros superiores.
- B) La ingurgitación venosa del cuello es un signo precoz.
- C) La radiografía de tórax debe solicitarse con carácter urgente.
- D) La colocación de stents endovasculares en pacientes graves está indicada.

- 59 En la inmovilización de fracturas, señale a la correlación INCORRECTA:**
- A) Fractura clavícula no desplazada – Cabestrillo.
 - B) Fractura clavícula desplazada – Vendaje de Velpeau.
 - C) Fractura C2 – Collarín tipo Philadelphia.
 - D) Fractura D11-L1 – Corsé de material termoplástico.
- 60 Respecto a los signos de alarma en el lactante que llora, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Cede con la comida.
 - B) Fiebre.
 - C) Vómitos.
 - D) Diarrea.
- 61 Referido a la bronquiolitis aguda, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) El diagnóstico es clínico.
 - B) Cursa con fiebre, rinitis, tos y disnea.
 - C) Se da en niños menores de 2 años.
 - D) El agente etiológico principal es el rinovirus.
- 62 En las lesiones meniscales de rodilla, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Son frecuentes en jóvenes deportistas y en mayores de 50 años.
 - B) Se produce por giro de la rodilla con el pie fijo.
 - C) En el test de McMurray el talón señala el menisco sano.
 - D) El tratamiento ortopédico se realiza con vendaje compresivo.
- 63 En el paciente con celulitis orbitaria, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Está originada por infecciones o traumatismos.
 - B) Se caracteriza por fiebre y leucocitosis.
 - C) No requiere ingreso hospitalario.
 - D) Precisa siempre de tratamiento antibiótico.
- 64 En la intoxicación aguda por antidepresivos tricíclicos, señale la respuesta correcta:**
- A) Causan hipertensión grave.
 - B) El riesgo de cardiotoxicidad se correlaciona con los valores plasmáticos de los antidepresivos tricíclicos.
 - C) El periodo de observación es más corto en pacientes de edad avanzada.
 - D) Está contraindicada la administración de Flumazenilo.
- 65 Respecto al eFAST, según el Proceso Asistencial Integrado (PAI) de la Atención al Trauma Grave (2ª edición, 2020), señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) No está indicada en pacientes con inestabilidad hemodinámica.
 - B) Debe incluir un examen de abdomen, pericardio y pleura.
 - C) Si es negativa, no excluye sangrado intraperitoneal.
 - D) Si es negativa, no excluye sangrado retroperitoneal.

- 66 En la infección por herpes zoster, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Comienza con un pródromo que consiste en la aparición de vesículas.
 - B) Los síntomas varían desde prurito a dolor lancinante.
 - C) Se caracterizan por la unilateralidad y localización metamérica.
 - D) El tratamiento antiviral es eficaz si se administra durante las primeras 72 horas.
- 67 En el tratamiento de la hidradenitis supurativa leve (Hurley I), señale la respuesta correcta:**
- A) Tetraciclina.
 - B) Rifampicina.
 - C) Prednisona.
 - D) Adalimumab.
- 68 ¿Qué fármacos son desencadenantes de síndrome confusional agudo o delirium?**
- A) Opiáceos.
 - B) Antihistamínicos.
 - C) Anticolinérgicos.
 - D) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
- 69 En el paciente con ojo rojo, señale la correlación INCORRECTA:**
- A) Conjuntivitis – Secreción.
 - B) Queratitis – Fotofobia.
 - C) Glaucoma agudo - Dolor.
 - D) Hemorragia subconjuntival – Visión afectada.
- 70 ¿Cuál de estos antieméticos tiene evidencia de mayor riesgo fetal durante el embarazo, según la FDA?**
- A) Doxilamina más piridoxina.
 - B) Metoclopramida.
 - C) Ondansetron.
 - D) Domperidona.
- 71 Respecto a las recomendaciones de la inmovilización raquídea, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Combinar collarín rígido con inmovilización tetracameral (dama de Elche) y un tablero espinal.
 - B) Combinar collarín cervical con un colchón de vacío.
 - C) Se recomienda en la práctica habitual el uso bolsas de arena y cintas adhesivas.
 - D) No se recomienda en pacientes con traumatismos penetrantes.
- 72 En la intoxicación aguda por litio, señale la respuesta correcta:**
- A) El litio se elimina casi en su totalidad sin transformar por el riñón.
 - B) Las manifestaciones digestivas (vómitos y diarrea) son tardías.
 - C) Los cambios electrocardiográficos incluyen depresión del segmento ST e inversión de la onda T.
 - D) La hemodiálisis está contraindicada.

- 73 En el neumotórax abierto (tórax soplante), señale la respuesta correcta:**
- A) No es una lesión torácica vital.
 - B) Se produce por una herida torácica abierta con una apertura en el tórax de un tercio del diámetro de la tráquea.
 - C) Inicialmente, la herida abierta debe cubrirse con un parche de sellado de tórax.
 - D) El tratamiento definitivo es la colocación de un drenaje pleural lo más cercano posible de la herida.
- 74 En la toracocentesis de emergencia del hemotórax masivo, señale la respuesta correcta:**
- A) 2º espacio intercostal, línea claviclar media.
 - B) 2º espacio intercostal, línea axilar media.
 - C) 5º espacio intercostal, línea claviclar media.
 - D) 5º espacio intercostal, línea axilar media.
- 75 Respecto a las características de los hospitales útiles, según el PAI de la Atención al Trauma Grave (2ª edición, 2020), señale la respuesta correcta:**
- A) Hospital útil nivel III: No dispone de Tomografía Computarizada 24 horas.
 - B) Hospital útil nivel II: No dispone de Neurocirugía.
 - C) Hospital útil nivel I: No dispone de Resonancia Magnética Nuclear 24 horas.
 - D) Hospital Alta Resolución: No adecuados para atender pacientes traumatizados graves.
- 76 En el diagnóstico de la enfermedad por virus Ébola, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Es una fiebre hemorrágica.
 - B) La mortalidad es del 30-40%.
 - C) El periodo de incubación oscila de 2 a 21 días.
 - D) La transmisión es por contacto directo con fluidos corporales.
- 77 En el traumatismo abdominal abierto con hemorragia no controlada, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Compresión directa manual.
 - B) Reposición enérgica de líquidos.
 - C) Mantener una presión arterial sistólica 80-90 mmHg.
 - D) Laparotomía inmediata.
- 78 En la intoxicación aguda por benzodiacepinas, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Su efecto es potenciado por el alcohol.
 - B) Producen taquicardia e hipotensión arterial.
 - C) La administración de carbón activado es útil dentro de la primera hora tras la ingesta del tóxico.
 - D) Su antagonista específico es el Flumazenil en dosis inicial de 0,3 mg en bolo intravenoso.

- 79 El signo de Nikolsky positivo (desprendimiento epidérmico al friccionar la piel) puede aparecer en las siguientes enfermedades, EXCEPTO una:**
- A) Necrólisis epidérmica tóxica.
 - B) Síndrome de la piel escaldada estafilocócica.
 - C) Pénfigo vulgar.
 - D) Penfigoide ampolloso.
- 80 En la parálisis facial periférica idiopática, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) La mayoría de pacientes mejoran después de las tres semanas.
 - B) El pronóstico es mejor cuanto menor sea el grado de paresia.
 - C) Presenta desviación de la boca hacia el lado sano.
 - D) Presenta dificultad de cierre del ojo del lado afecto.
- 81 Respecto a las fracturas del extremo proximal de fémur (fractura de cadera), señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) La causa principal es una caída fortuita.
 - B) El acortamiento y la rotación externa del miembro lesionado es patognomónico de este tipo de fractura.
 - C) Las fracturas subcapitales y transcervicales, son intraarticulares.
 - D) Las fracturas basicervicales, pertrocantéreas y subtrocantéreas, son extraarticulares.
- 82 Se encuentra atendiendo a un paciente con sospecha de TBC en urgencias. Señale la respuesta ERRÓNEA:**
- A) Colocación de mascarilla al paciente, instaurar medidas de aislamiento, y solicitar analítica con hemograma, bioquímica con perfil hepático y coagulación.
 - B) Una baciloscopia urgente. Contactar con microbiología de guardia para realización de la tinción de Ziehl-Nielsen urgente, de cara a detectar bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR).
 - C) Dada la variabilidad existente respecto a la positividad de la baciloscopia (dependerá de la cantidad de bacilos/mL en la muestra), un resultado negativo descarta la enfermedad tuberculosa.
 - D) Cultivo de esputo para micobacterias (Cultivo de Löwenstein). Identifica el tipo de micobacteria y permite realizar el antibiograma.
- 83 Ante un paciente que llega a urgencias con una hemoptisis masiva, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es la ERRÓNEA?**
- A) Pérdida sanguínea superior a 300 ml en 24h.
 - B) Rapidez de sangrado superior a 100 ml/h.
 - C) Inestabilidad hemodinámica.
 - D) Disfunción respiratoria con alteración del intercambio gaseoso.

- 84 Con respecto al diagnóstico radiológico en urgencias de pacientes con sospecha de tuberculosis, ¿cuál de las siguientes opciones considera correcta?**
- A) La Radiografía Simple de Tórax, es raro que sea normal en pacientes con tuberculosis pulmonar activa, mostrando una alta sensibilidad con una alta especificidad.
 - B) La Tomografía Computarizada (TC) es una técnica más sensible y específica que la radiografía para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar activa.
 - C) La RMN se considera la prueba diagnóstica de elección en pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar.
 - D) La Gammagrafía y la Tomografía por Emisión de Positrones (PET), muestran resultados específicos para el diagnóstico de TB de localización extratorácica.
- 85 Señale la respuesta INCORRECTA en relación al SCACEST que opta por la fibrinólisis (FL) intravenosa (i.v.):**
- A) En el primer contacto médico (PCM), obtención y lectura de un ECG en menos de 10 minutos.
 - B) Si se opta por la actitud terapéutica de realizar una FL i.v. se debe de realizar en < 30 min.
 - C) Instaurar tratamiento antiagregante con AAS 250-300 mg y Clopidogrel 300 mg.
 - D) Anticoagulación con Enoxaparina preferentemente.
- 86 De las siguientes causas de dolor torácico agudo, ¿cuál de ellas suele cursar con frecuencia con inestabilidad hemodinámica?**
- A) Pericarditis seca.
 - B) Perforación esofágica.
 - C) Derrame pleural.
 - D) Herpes zóster.
- 87 Recibe en Urgencias un paciente en coma, con presencia de tono muscular y signos simétricos de afectación neurológica y con funciones del tronco cerebral intactas. La causa más frecuente sería:**
- A) Vascular.
 - B) Metabólica.
 - C) Desmielinizante.
 - D) Degenerativa.
- 88 Señale cuál de los siguientes signos radiológicos pueden aparecer en la Rx de tórax ante la presencia de un neumomediastino:**
- A) El signo "V" de Naclerio, que es aire libre en mediastino delineando el diafragma.
 - B) Desplazamiento anterior de la tráquea.
 - C) Ensanchamiento del mediastino.
 - D) Todas son correctas.

89 En relación a la mediastinitis, señale la respuesta ERRÓNEA:

- A) La etiología es infecciosa en la mayoría de los casos.
- B) El cuadro clínico habitual cursa con dolor torácico y cervical, y puede asociar a disnea y malestar general.
- C) Es una infección que raramente evoluciona a shock séptico.
- D) La realización de una TAC de tórax será fundamental para su diagnóstico.

90 De las siguientes causas de dolor torácico agudo, ¿cuál de ellas suele cursar con frecuencia con inestabilidad hemodinámica?

- A) Pericarditis seca.
- B) Perforación esofágica.
- C) Derrame pleural.
- D) Brote ulceroso.

91 De las siguientes aseveraciones, indique la que NO se corresponde con un dolor torácico por consumo de cocaína:

- A) Presenta midriasis e hipertensión.
- B) Tiene una duración que puede oscilar desde minutos a 2-3 horas.
- C) Suele acompañarse de taquicardia y taquipnea.
- D) Empeora con la toma de Nitroglicerina.

92 Ante un paciente con neumotórax a tensión, indique qué hallazgo de los siguientes en la exploración NO es compatible con dicho proceso:

- A) Desviación contralateral del mediastino.
- B) Disminución de la ventilación y de los movimientos respiratorios.
- C) Hiperresonancia con la percusión.
- D) La presión intrapleurale es inferior a la atmosférica.

93 En relación a la presencia de una atelectasia en una radiografía de tórax, indique la respuesta FALSA:

- A) Aumento de densidad radiológica del área afectada.
- B) Aplanamiento y descenso diafragmático en las atelectasias de lóbulos basales.
- C) Desplazamiento de la cisura adyacente hacia la zona colapsada.
- D) Enfisema compensador del parénquima no afectado.

94 ¿Cuál de las siguientes causas de derrame pleural NO es un exudado?

- A) Amiloidosis.
- B) Artritis reumatoide.
- C) Glomerulonefritis.
- D) Cáncer de mama.

95 ¿Cuál de las siguientes causas de derrame pleural NO es un trasudado?

- A) Síndrome nefrótico.
- B) Tromboembolia pulmonar.
- C) Síndrome de Meigs.
- D) Insuficiencia cardíaca.

- 96 Una puntuación de 100 en la escala de valoración pronóstica PSI para la Neumonía Adquirida en la Comunidad corresponde a la clase de riesgo:**
- A) II.
 - B) III.
 - C) IV.
 - D) V.
- 97 El modo presión de soporte o BIPAP es un modo de ventilación mecánica no invasiva. Señale la FALSA:**
- A) Los disparos del respirador son independientes de la respiración espontánea del paciente.
 - B) Es un modo controlado por presión.
 - C) El paso a espiración se relaciona con los cambios en el flujo inspiratorio.
 - D) Es el modo ventilatorio más usado.
- 98 En relación a la clasificación International League Against Epilepsy de las crisis epilépticas, ¿cuál de las siguientes NO se engloba dentro de las crisis generalizadas?**
- A) Complejas con alteración de la conciencia.
 - B) Ausencias.
 - C) Mioclónicas.
 - D) Tónico-clónicas.
- 99 Ante un paciente que presenta una hipomagnesemia, debemos sospechar todas las situaciones siguientes EXCEPTO:**
- A) Intoxicación digitálica que no responde al tratamiento médico habitual.
 - B) Uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones.
 - C) Paciente con Torsades de pointes.
 - D) Hiperpotasemia.
- 100 ¿Cuál es la alteración electrocardiográfica característica de la hipocalcemia?**
- A) Ondas T picudas y simétricas.
 - B) Acortamiento del intervalo QT.
 - C) Prolongación del intervalo QT.
 - D) Aparición de ondas U.

SAS_MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA 2023 / TURNO LIBRE / PRUEBA APLAZADA

CUESTIONARIO PRÁCTICO

CASO PRÁCTICO 1:

Mujer de 36 años, asmática desde la juventud, que desde hace 2 días presenta tos, opresión torácica, disnea y autoescucha de sibilancias. Refiere que además de su tratamiento habitual, se ha visto obligado a usar SABA (beta-2 adrenérgicos de corta duración) de rescate. Consulta en el servicio de urgencias donde se le detectan los siguientes signos clínicos: afebril, consciente y alerta, tensión arterial de 105/56, frecuencia cardíaca de 116 lpm (latidos por minuto), frecuencia respiratoria de 23 rpm (respiraciones por minuto) con evidente uso de la musculatura respiratoria accesoria, presencia de sibilancias y saturación de oxígeno del 93%.

101 Señale la respuesta correcta:

- A) Se trata de una crisis asmática vital.
- B) Se trata de una crisis asmática moderada.
- C) Se trata de una crisis asmática leve.
- D) Se trata de una crisis asmática grave.

102 Respecto a la paciente de la pregunta anterior, ¿qué actitud en su manejo en urgencias sería la adecuada?

- A) Realizar una única medición del PEF (flujo espiratorio máximo) mediante medidor de Peak-Flow antes de iniciar tratamiento, y calcular el porcentaje respecto al valor teórico según sexo, edad y altura, independientemente de los valores conocidos por la paciente durante la fase estable de la enfermedad.
- B) Realizar tres mediciones del PEF mediante medidor de Peak-Flow (escoger la mejor) antes de iniciar tratamiento, y calcular el porcentaje respecto al valor teórico según sexo, edad y altura, salvo que la paciente conozca su valor personal durante la fase estable de la enfermedad.
- C) Realizar tres mediciones del PEF mediante medidor de Peak-Flow (escoger la mejor) antes de iniciar tratamiento, y calcular el porcentaje respecto al valor teórico según sexo, edad y altura, independientemente de los valores conocidos por la paciente durante la fase estable de su enfermedad.
- D) Realizar una única medición del PEF mediante medidor de Peak-Flow antes de iniciar tratamiento, y calcular el porcentaje respecto al valor teórico según sexo, edad y altura, salvo que la paciente conozca su valor personal durante la fase estable de su enfermedad.

103 Indique qué tratamiento estaría indicado en nuestra paciente:

- A) Salbutamol + Ipratropio pMDI (pressured metered dose inhaler): 4-8 inhalaciones cada 10-15 minutos durante la primera hora.
- B) Hidrocortisona 250 mg vía endovenosa.
- C) Prednisona 50 mg vía oral.
- D) Todas son correctas.

104 A las 2 horas de la administración del tratamiento correcto, la paciente presenta un PEF (flujo espiratorio máximo) > 60%, y los síntomas han desaparecido. Señale la respuesta correcta:

- A) Ingresar en observación para vigilancia en las siguientes 24 h (horas) por el riesgo de broncoespasmo.
- B) Indicar el alta con Salbutamol a demanda.
- C) Indicar el alta con Prednisona 50 mg cada 24 h durante 5-7 días, glucocorticoide inhalado y LABA (fármacos anticolinérgicos inhalados de acción prolongada), un plan de acción y concretando una cita de control.
- D) Solicitar analítica con tres series y radiografía de tórax.

105 En el supuesto de que la paciente, tras la administración en urgencias el tratamiento correcto, presentara persistencia de los síntomas y un PEF 52 %, ¿cuál sería la actitud más adecuada?

- A) Ingreso en una unidad de cuidados intensivos (UCI).
- B) Ingreso en observación y administrar nebulización intermitente con 2.5 mg de Salbutamol más 0,5 mg de Ipratropio cada 4-6 horas.
- C) Ingreso en observación y administrar Hidrocortisona 100-200 mg cada 6 horas.
- D) Las respuestas B) y C son correctas.

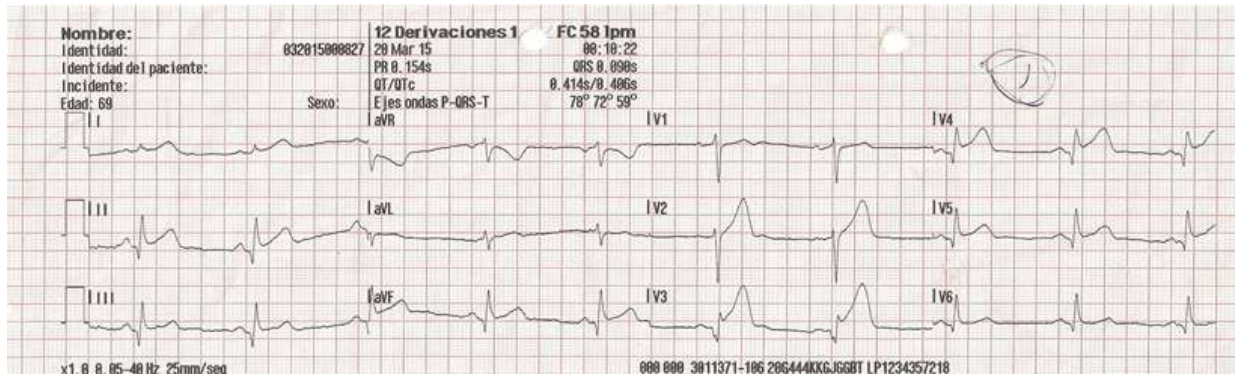
CASO PRÁCTICO 2:

Aviso al centro de emergencias sanitarias (CES) a las 00:30h por dolor torácico, en cortijo situado en la serranía de difícil acceso, en varón de 69 años fumador hasta hace 6 meses sin otros factores de riesgo cardiovascular. A las 22:50 horas, estando en reposo comienza con dolor centrotorácico opresivo acompañado de náuseas y vómitos de unos 30 min de duración. A nuestra llegada a las 00:50 horas se encuentra pálido y sudoroso, afectado por el dolor. Tensión arterial 173/107 mmHg, saturación de oxígeno < 90%. Resto de exploración normal.

106 De las siguientes aseveraciones diga cuál es la INCORRECTA en la primera asistencia al paciente:

- A) Monitorización electrocardiográfica continua con desfibrilación precoz si precisa.
- B) Realización de ECG de 12 derivaciones lo antes posible.
- C) Oxigenoterapia precoz con gafas nasales a un flujo de 2 L/min.
- D) Extracción de gasometría arterial.

107 Realizamos el siguiente ECG. ¿Qué actitud debemos tomar en este caso?

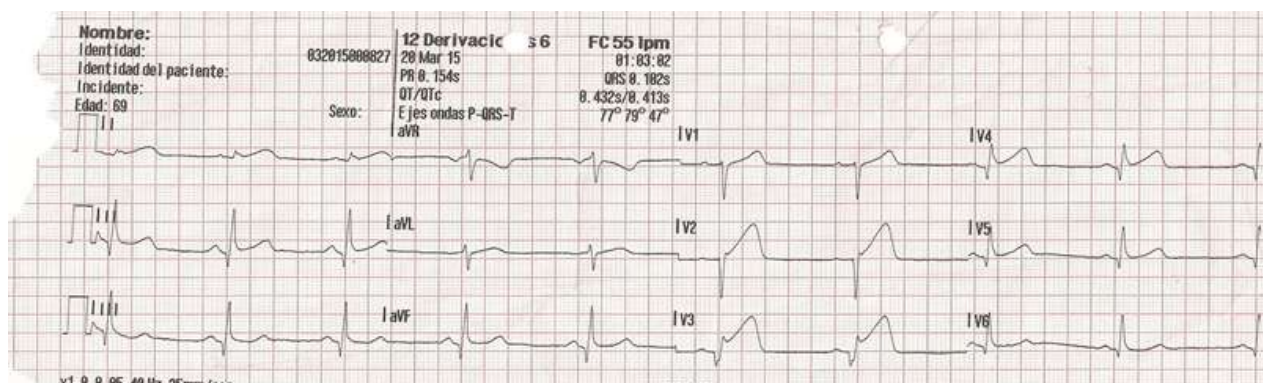


- A) Lo derivo directamente al centro hospitalario cercano (Hospital comarcal) para allí comenzar con tratamiento.
- B) Se trata de un SCACEST: Canalización de vía venosa periférica (vvp), doble antiagregación, tratamiento antianginoso, anticoagulación con Fondaparinux y traslado a hospital con posibilidad de ICP.
- C) Se trata de un SCACEST: vvp, doble antiagregación, tratamiento antianginoso, anticoagulación con Enoxaparina i.v. y realizo fibrinólisis i.v.
- D) Traslado al Hospital de referencia sin administrar pretratamiento antiagregante, y tomar allí la decisión de tratamiento de reperfusión.

108 ¿Cuál es el tratamiento médico inicial en este caso?

- A) AAS 100 mg vía oral (vo) Enoxaparina 30 mg i.v., NTG i.v., Meperidina i.v.
- B) AAS 300 mg vo, Clopidogrel 300 mg vo, Enoxaparina 30 mg i.v., NTG i.v., Meperidina i.v.
- C) AAS 300 mg vo, Ticagrelor 180 mg vo, Enoxaparina 30 mg i.v., NTG i.v., Cloruro Mórfico i.v.
- D) AAS 300 mg vo, Prasugrel 60 mg vo, Enoxaparina 30 mg i.v., NTG, cloruro mórfico i.v.

109 Tras derivación a Hospital comarcal más cercano, y después de 60 minutos tras la fibrinólisis, el paciente continúa con dolor. Repetimos el ECG, que puede ver a continuación. ¿Qué hacemos ahora?



- A) Tras la fibrinólisis no cumple criterios de reperfusión, por lo que organizo traslado urgente a hospital capacitado para ICP de rescate.
- B) El ECG muestra criterios de reperfusión, traslado a hospital para ICP sistemática tras fibrinólisis.
- C) Tras bolo de fibrinólisis no cumple criterios de reperfusión, por lo que repito dosis de fibrinolítico.
- D) Tras fibrinólisis el ECG no muestra cambios, por lo que hay que remitir a cirugía urgente de revascularización.

110 Se contacta con la sala de hemodinámica, y se traslada a hospital de referencia. Tras colocación de stent fármaco activo (SFA), indique la respuesta FALSA sobre el tratamiento antiplaquetario doble (TAPD) al alta:

- A) Está recomendado el TAPD con AAS con un inhibidor de la P2Y12 durante los 12 meses siguientes a la ICP.
- B) Para los pacientes con riesgo alto de complicaciones hemorrágicas importantes, debe considerarse interrumpir el tratamiento inhibidor del P2Y12 a los 12 meses.
- C) Debe considerarse agregar un segundo antiagregante al AAS para la prevención secundaria a largo plazo en pacientes con alto riesgo isquémico y sin riesgo de complicaciones hemorrágicas.
- D) No se recomienda usar el Ticagrelor o el Prasugrel como parte del tratamiento antitrombótico triple con AAS y anticoagulación oral.

CASO PRÁCTICO 3:

Un paciente de 62 años hipertenso, diabético tipo II e hipercolesterolémico, es encontrado por su jefe a las 9:00 a.m. en la oficina desorientado con clínica compatible afasia global. Previamente era independiente para las actividades de la vida diaria y no presentaba ninguna limitación. El paciente vive solo y cenó con unos amigos la noche anterior. Suele salir de su casa a las 7:40 a.m. y llegar al trabajo a las 8:00 a.m. Nadie había hablado con él desde su llegada al trabajo.

111 ¿Qué hora asumiremos como hora de inicio de los síntomas?

- A) La hora en la que se despidió de sus amigos tras la cena.
- B) A las 7:40 a.m.
- C) A las 8:00 a.m.
- D) A las 9:00 a.m.

112 El paciente, que vive en zona rural, es trasladado por el SUAP al Hospital comarcal que se encuentra a 20 minutos de su localidad. De las siguientes medidas iniciales que debe de aplicar, ¿cuál es la MENOS indicada?

- A) Canalizar vía venosa en miembro no parético.
- B) Realizar glucemia capilar.
- C) Poner gafas nasales a 1.5 L/min de forma sistemática.
- D) Asegurar vía aérea, ventilación, circulación.

113 A su llegada al hospital comarcal, el paciente presenta tensión arterial 195/115, saturación de oxígeno de 96%, glucemia capilar de 188 mg/dl, y electrocardiograma en Fibrilación Auricular a 90 lpm. De las siguientes medidas a realizar, ¿cuál de las siguientes NO está indicada?

- A) Labetalol 20 mgr i.v. en 1-2 minutos.
- B) AAS 300 mgr más HBPM a dosis profilácticas.
- C) Retirar gafas nasales.
- D) Insulina rápida vía subcutánea.

114 Al aplicar la escala NIHSS (*National institute of Health Stroke Scale*) obtiene una puntuación de 7 puntos (afasia global: 2+2+3). ¿Qué haría en estos momentos?

- A) TAC craneal de perfusión urgente.
- B) Iniciar inmediatamente, como primera acción, fibrinólisis i.v. con rt-PA 0.9 mg/kg, 10% en 2 min y resto en perfusión durante 60 min.
- C) Traslado al hospital de referencia sin necesidad de administración de fibrinolítico.
- D) Las respuestas A) y B) son correctas.

115 Al recibir la TAC craneal se informa como presencia de hiperdensidad de ACM (arteria cerebral media) izquierda (M1). La puntuación de la escala NIHSS apenas ha mejorado (6 puntos), presentando las siguientes constantes: tensión arterial 205/115, glucemia 140 y satO2 del 97%. ¿Cómo actuaría en este momento?

- A) Administración de perfusión de rt-PA a 0,9 mg/kg.
- B) Administrar antihipertensivo de manera urgente.
- C) Derivación a hospital de referencia para plantear posible trombectomía.
- D) Las respuestas A) y C) son correctas.

CASO PRÁCTICO 4:

Varón de 36 años, sin antecedentes de interés. Llevado en ambulancia a Urgencias del hospital por caída en domicilio con tumefacción y hematoma en región frontotemporal derecha, sin pérdida de conocimiento ni amnesia, ni otra sintomatología de alarma neurológica. A su llegada presenta apertura ocular al sonido, palabras sueltas inteligibles, obedece órdenes con respuesta motora adecuada. Presión arterial (PA)

120/60 mmHg. Frecuencia cardiaca 100 latidos por minuto (lpm).

116 ¿Qué puntuación le corresponde según la escala de Coma de Glasgow?

- A) 14 puntos.
- B) 13 puntos.
- C) 12 puntos.
- D) 11 puntos.

117 Según su gravedad, en función de la puntuación en la escala de Glasgow, ¿cómo lo clasificamos?

- A) TCE leve.
- B) TCE moderado.
- C) TCE grave.
- D) Ninguna de las anteriores.

118 ¿Qué exploración complementaría de urgencia estaría indicada?

- A) TC craneal.
- B) TC cervical.
- C) Rx craneal.
- D) Las opciones A) y B) son correctas.

119 Respecto a las intervenciones en este paciente, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Debería evitarse una saturación de O₂ < 90%.
- B) La hiperventilación profiláctica prolongada es recomendable.
- C) El objetivo hemodinámico es mantener la presión arterial sistólica > 110 mm Hg.
- D) Los cristaloideos isotónicos son los fluidos intravenosos de elección.

120 El paciente presenta vómitos “en escopetazo”, con posterior deterioro del nivel de conciencia (Glasgow 8 puntos), PA 160/100 mmHg, Frecuencia cardiaca 45 lpm. Respecto a las medidas terapéuticas recomendadas en estos momentos, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Intubación orotraqueal y ventilación mecánica.
- B) Manitol 0,25-1 g/kg en bolo intravenoso.
- C) Dexametasona 8 mg en bolo intravenoso.
- D) Levetiracetam intravenoso como profilaxis de convulsión.

CASO PRÁCTICO 5:

Mujer de 42 años, diagnosticada de cáncer de mama hace 3 años, tratado con cirugía y quimioterapia durante 12 meses, y con metástasis vertebrales (D12, L1) en la última revisión hace 1 mes. Es traída a Urgencias por presentar, desde hace unas horas, un estado de fatigabilidad y debilidad progresiva. La familia refiere que en la última semana se quejaba de que orinaba mucho, bebía mucha agua y no tenía ganas de comer. Tenía náuseas y algún vómito aislado. Exploración física: paciente con afectación del estado general, normocoloreada y eupneica. Auscultación cardiorrespiratoria, palpación abdominal y exploración neurológica sin alteraciones. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios: hematocrito 52%, resto normal;

bioquímica sanguínea: glucosa 97 mg/dl, urea 85 mg/dl, creatinina 1,2 mg/dl, sodio 155 mEq/l, potasio 3,2 mEq/l. EKG: Ritmo sinusal a 60 spm con QT de 250 milisegundos.

121 Con los datos de la historia clínica, ¿qué exploración complementaria solicitaría en primer lugar?

- A) TC craneal.
- B) Rx columna dorsolumbar.
- C) Calcemia y proteínas totales.
- D) Sodio y creatinina en orina.

122 ¿Cuál de las siguientes medidas se incluye en el tratamiento de esta paciente?

- A) Solución glucosada.
- B) Cloruro potásico.
- C) Furosemida.
- D) Las opciones B) y C) son correctas.

123 ¿Cuál de los siguientes fármacos es de elección para tratar a esta paciente?

- A) Ácido zoledrónico.
- B) Hidrocortisona.
- C) Metilprednisolona.
- D) Las opciones B) y C) son correctas.

124 La paciente refiere dolor en columna lumbar de características mecánicas, y con una intensidad en la escala visual analógica de 8/10. Está tratada con Paracetamol 1 g/6 horas y Naproxeno 500 mg/8 horas, ambos por vía oral. ¿Qué tratamiento para el dolor iniciamos?

- A) Indometacina.
- B) Tramadol.
- C) Metamizol.
- D) Dexketoprofeno trometamol.

125 Al cabo de 2 horas, la paciente refiere el dolor con una intensidad en la escala visual analógica de 7/10. ¿Qué fármaco estaría indicado prescribirle en esta situación?

- A) Tramadol.
 - B) Fentanilo.
 - C) Dexametasona.
 - D) Las opciones contempladas en las respuestas B) y C) son correctas.
-

CASO PRÁCTICO 6:

Varón joven que es trasladado en ambulancia convencional por caída desde una altura de más de 3 metros, hace 30 minutos. Lleva un collarín cervical tipo Philadelphia. No ha sido posible canalizar vía venosa. El paciente comenta que ha recibido un traumatismo costal izquierdo. Niega contusiones en otras localizaciones. Viene con el torso desnudo, y se observa una erosión extensa en costado y fosa renal izquierda. No heridas sangrantes en costado ni resto del cuerpo. A los pocos minutos, deja de hablar,

pierde el conocimiento y no responde.

126 ¿Qué actuación estaría indicada a continuación?

- A) Garantizar la permeabilidad de la vía aérea.
- B) Monitorizar la tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno.
- C) Determinar glucemia capilar.
- D) Valorar nivel de conciencia y pupilas.

127 El paciente muestra una marcada ingurgitación yugular izquierda, hipoventilación en hemitórax izquierdo con timpanismo. PA 80/40 mmHg, FC 120 lpm, SatO₂ 92%, FR 25 rpm. ¿Cuál sería la actitud prioritaria correcta?

- A) Toracotomía.
- B) Drenaje torácico.
- C) Pericardiocentesis.
- D) Intubación orotraqueal y ventilación mecánica.

128 Tras la actuación anterior, el paciente no mejora significativamente. Está sudoroso. PA 80/50 mmHg, FC 120 lpm, relleno capilar 3 segundos. ¿Qué estaría indicado hacer sin demora?

- A) Canalización una vía venosa central.
- B) Soluciones cristaloides.
- C) Soluciones coloides.
- D) Todas las anteriores.

129 Tras la actuación anterior, el paciente evoluciona favorablemente. PA 110/60 mmHg, FC 100 lpm. ¿Qué valoración estaría indicada a continuación?

- A) Escala de coma de Glasgow.
- B) Valoración de pupilas.
- C) Signos de lesión cerebral o medular.
- D) Todas las anteriores.

130 ¿Qué prueba complementaria es el “gold estándar”, si está disponible de forma inmediata?

- A) Rx tórax.
 - B) Ecografía FAST.
 - C) Tomografía axial computarizada (TAC) de tórax con contraste.
 - D) TAC de tórax sin contraste.
-

CASO PRÁCTICO 7:

Paciente de 18 años que es derivada a Urgencias, tras aviso de la familia, por ingesta de un blíster completo de 25 comprimidos de Lorazepam de 1 mg hace menos de una hora. Antecedentes personales: depresión, obesidad (IMC 30, peso estimado 80 kg).

Exploración física: A (vía aérea permeable), B (oxigenación y ventilación adecuada, Saturación de O₂ 98%), C (Auscultación cardio-respiratoria normal, Frecuencia Cardíaca 70 latidos por minuto, Presión Arterial 130/70 mmHg, Buen relleno capilar), D (Escala de Glasgow 15 puntos, pupilas normales, glucemia 85 mg/dl), E (Temperatura

36°C). Tiene canalizada una vía venosa periférica y se le cursan pruebas complementarias, incluido examen toxicológico.

131 ¿Qué actuación está indicada?

- A) Carbón activado.
- B) Diuresis forzada.
- C) Flumazenilo.
- D) Todas las anteriores.

132 Durante su estancia en urgencias, la paciente presenta deterioro neurológico (Escala de Glasgow 10 puntos) y respiratorio (Frecuencia Respiratoria 10 respiraciones por minuto.) ¿Qué medidas terapéuticas están indicadas?

- A) Intubación endotraqueal + ventilación mecánica + Flumazenilo 0,3 mg bolo intravenoso (i.v.) cada 30 segundos.
- B) Intubación endotraqueal + ventilación mecánica + Flumazenilo 0,6 mg bolo i.v. cada 30 segundos.
- C) Ventilación bolsa-mascarilla + Flumazenilo 0,3 mg bolo i.v. cada 30 segundos.
- D) Ventilación bolsa-mascarilla + Flumazenilo 0,6 mg bolo i.v. cada 30 segundos.

133 ¿Cuál es la dosis máxima acumulada de administración de Flumazenilo en bolos i.v.?

- A) 2,4 mg.
- B) 3 mg.
- C) 3,6 mg.
- D) 4,2 mg.

134 La paciente no mejora el nivel de conciencia ni la frecuencia respiratoria, y evidencia, en una nueva exploración neurológica, pupilas mióticas. ¿Qué actitud priorizaría, ante esta situación?

- A) Añadir Naloxona 0,4 mg i.v.
- B) Añadir Naloxona 0,8 mg i.v.
- C) Solicitar TAC craneal.
- D) Las respuestas A) y C) son correctas.

135 Los resultados toxicológicos informan de niveles altos de benzodicepinas y opiáceos, y tras nueva entrevista con la familia, comentan que han advertido la ausencia de una cantidad indeterminada de comprimidos de Fentanilo que tenía prescrito la madre. ¿Qué dosis de Naloxona es la correcta ante esta situación?

- A) 0,4 mg i.v.
- B) 0,8 mg i.v.
- C) 4 mg i.v.
- D) 8 mg i.v.

CASO PRÁCTICO 8:

Llega a nuestro servicio de Urgencias un paciente de 85 años, independiente para las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD), diabético mal controlado, hipertenso, con cardiopatía isquémica monovaso (estable). Su motivo de consulta es un progresivo deterioro del estado general desde hace 3 días, con escalofríos y fiebre termometrada de hasta 39,5°C. Nivel de conciencia sin alteraciones, Escala de Glasgow (GCS) 15/15 y sin otros síntomas en anamnesis por aparatos. Las constantes a su llegada son: Presión Arterial 87/48 mmHg, Presión Arterial Media (PAM) 61; Frecuencia Cardíaca 110 latidos por minuto (lpm); Temperatura 38,3°C; Saturación de O₂ sin terapia de O₂ suplementario: 91%; Frecuencia respiratoria 32 respiraciones por minuto. En la exploración inicial no encontramos un foco infeccioso claro.

136 Con toda esta información, señale la respuesta correcta:

- A) No estaría indicado activar el Código Sepsis, puesto que el qSOFA es de 2 puntos.
- B) Estaríamos ante un shock séptico.
- C) Administraremos Dopamina a dosis de 2 mcg/kg/h.
- D) Tras toma de muestras para hemocultivos, administraremos antibioterapia empírica a ser posible en la 1ª hora.

137 En cuanto a las pruebas complementarias que solicitaría, ¿cuál es la cierta?

- A) Solicitaremos hemograma, coagulación, bioquímica (con bilirrubina, PCR y procalcitonina), orina, gasometría con lactato y hemocultivos.
- B) Trasladaría al paciente lo antes posible del box de Emergencias al Servicio de Radiodiagnóstico para realizar Tomografía Axial Computarizada (TAC) para buscar foco y dirigir la antibioterapia de forma más específica
- C) Sólo solicitaremos urocultivo si no encontramos foco tras la llegada del resto de pruebas complementarias (dada la escasa rentabilidad si no hay foco claro).
- D) Si el paciente muestra dolor abdominal, realizaremos eFAST a pie de la camilla.

138 Hemos canalizado vía periférica y comenzado a administrar fluidoterapia (suero fisiológico 0.9% a 42 ml/h). A pesar de ello, el paciente se mantiene hipotenso (PA 88/51 mmHg), Taquicárdico (121 lpm) y con saturación sin O₂ suplementario del 87%. ¿Qué medida NO adoptaría?

- A) Aumentar la velocidad de infusión de la fluidoterapia.
- B) Iniciar oxigenoterapia hasta conseguir O₂ por encima del 93%.
- C) Administrar Noradrenalina a dosis de 12 mcg/kg/min.
- D) Administrar 1 gr de Meropenem por vía intravenosa.

139 Llegan algunos resultados de la analítica solicitada, destacando:

-Hemograma: Leucocitos 23.900 (21.000 neutrófilos); Hemoglobina 7,1 dg/dl; Plaquetas 110.000.

-Bioquímica: creatinina 2.3 mg/dl; PCR 321 mg/l; procalcitonina 5.1 ng/dl; bilirrubina total 2.9 mg/dl.

-Gasometría arterial: pH 7.26; pO₂ 57 mmHg; pCO₂ 72 mmHg; Bicarbonato 25 mEq/l; ácido láctico 7.1 mmol/L.

-Coagulación: INR 2.0

Con toda esta información, señale la respuesta FALSA:

- A) Indicaremos transfusión de hematíes.
- B) Iniciaríamos Ventilación Mecánica No Invasiva.
- C) Administraremos Bicarbonato sódico intravenoso.
- D) Realizaremos Radiología de tórax en cuanto sea factible.

140 En el caso de que el paciente presente shock séptico y el foco infeccioso sea desconocido, ¿cuál de las pautas antimicrobianas es FALSA?

- A) Paciente con ingreso en UCI y más de 7 días de tratamiento antimicrobiano iniciar Ceftriaxona + Levofloxacino.
- B) Si el paciente no ha tenido tratamiento antibiótico previo podemos indicar Meropenem + Vancomicina.
- C) En pacientes procedentes de residencia geriátrica con casos de *Staphylococcus aureus* Meticilin resistente (SAMR) se puede asociar Linezolid.
- D) Si la infección es nosocomial se puede indicar Ceftazidima-Tazobactam en perfusión extendida.

CASO PRÁCTICO 9:

Acude a nuestro Servicio de Urgencias un varón de 64 años, diabético tipo 2 e hipertenso con buen control. Fumador de 24 paquetes/año y sin antecedentes cardiopulmonares destacables. Consulta por fiebre de hasta 38.3° (precedida de escalofríos), tos con escasa expectoración clara y dolor costal izquierdo de características pleuríticas. Todo ello de 3 días de evolución, con intensificación de la sintomatología en las últimas 24 horas, a las que se suma astenia y ligera sensación disneica. A su entrada en Urgencias presenta buen estado general, aunque con cierta taquipnea superficial sin tiraje, bien hidratado y perfundido, normocoloreado (sin cianosis ni palidez), con nivel de conciencia normal, Escala de Glasgow (GCS) 15/15. Sus constantes son las siguientes: Presión arterial (PA) 99/51 mmHg; Frecuencia cardiaca (FC) 90 latidos/minuto; Frecuencia Respiratoria (FR): 26 respiraciones/minutos; Saturación O₂ (FiO₂ ambiente) 92%; T^a 38.4°C. La auscultación muestra buen murmullo vesicular con crepitantes tenues en base y campos medios derechos. El latido es rítmico a 90 lpm, sin soplos ni extratonos.

141 De los siguientes enunciados indique el FALSO:

- A) Solicitaría hemocultivos, hemograma, bioquímica (con PCR, procalcitonina y bilirrubina), gasometría arterial (GSA), radiografía de tórax, electrocardiograma (EKG) y AG/PCR SARS-CoV-2.
- B) El tromboembolismo pulmonar podría ser uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta.
- C) De tratarse de una neumonía, su presentación clínica es atípica.
- D) Pensando en un proceso infeccioso, la puntuación de su qSOFA es 1.

142 Llegan los resultados de las pruebas complementarias: La Radiografía muestra infiltrado alveolar con broncograma aéreo en lóbulo medio derecho, sin otros hallazgos de interés. Destacamos del hemograma una leucocitosis (15.560 leucocitos/microlito) con neutrofilia, hemoglobina en 13.2 g/dl y Plaquetas 102.000 plaq/microlito. Bioquímica con creatinina 1,32 mg/dl (previas normales), urea 86 mg/dl, sodio 131 mEq/l, PCR 143 mg/l y procalcitonina 2,1 ng/dl. AG y PCR SARS-CoV-2 negativos. EKG en ritmo sinusal a 90 lpm sin alteraciones de la repolarización. GSA: pH 7.29, pO2 58 mmHg, pCO2 50 mmHg, Bicarbonato 19.8 mEq/l, EB -3.1. Lactato 3.2. Decidiríamos ampliar estudio con todas estas pruebas complementarias, EXCEPTO:

- A) Antígeno de legionella y neumococo en orina.
- B) Serología de VIH.
- C) Tinción GRAM y cultivo de esputo.
- D) Toracocentesis diagnóstica.

143 Podríamos estratificar la gravedad mediante la escala CURB-65, con una puntuación de:

- A) 0 puntos.
- B) 1 punto.
- C) 2 puntos.
- D) 3 puntos.

144 Formarían parte de nuestra actitud las siguientes respuestas, EXCEPTO una. Señálela:

- A) Administración de tratamiento antibiótico empírico precoz.
- B) Oxigenoterapia.
- C) Dopamina en perfusión intravenosa.
- D) Cristaloides intravenosos, al menos 30 ml/kg en las primeras 3 horas.

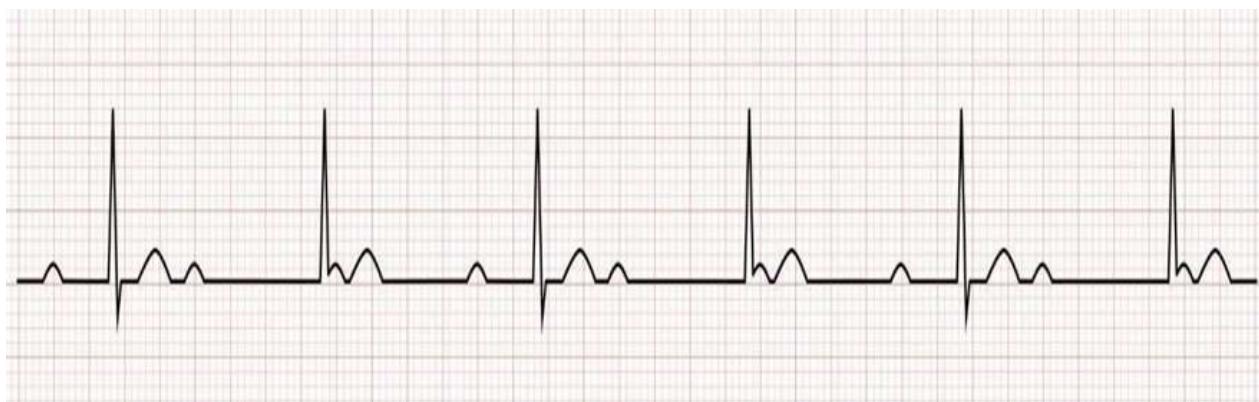
145 Respecto al tratamiento antibiótico, ¿qué pauta NO elegiría?

- A) Ceftriaxona 2 gr cada 24h + Azitromicina 500 mg cada 24h.
- B) Amoxicilina-Clavulánico 1-2 gr cada 8h + Azitromicina 500 mg cada 24h.
- C) Cefotaxima 2 gr i.v. cada 8 h + Moxifloxacino 400 mg i.v. cada 24h.
- D) Ceftriaxona 2 gr cada 24h + Linezolid 300 mg cada 24h.

CASO PRÁCTICO 10:

Paciente varón de 60 años, traído al Servicio de Urgencias hospitalario por el SUAP, por dolor torácico intenso. Lo han encontrado en su domicilio con bajo nivel de conciencia, vía aérea permeable, auscultación con crepitantes finos bibasales, Presión arterial 70/40 mmHg, FC 40 spm, Frecuencia Respiratoria 14 rpm, relleno capilar de 4 s. Presenta respuesta verbal, y no hay focalidad neurológica. Antecedentes Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Hipercolesterolemia. Tratamiento habitual: Metformina 850 mg /8h, Bisoprolol 5 mg /24h, Amlodipino 10mg/Olmesartan 40mg cada 24 h.

146 Si el EKG que presenta es el siguiente, ¿con qué terapia iniciaría el tratamiento de este paciente?

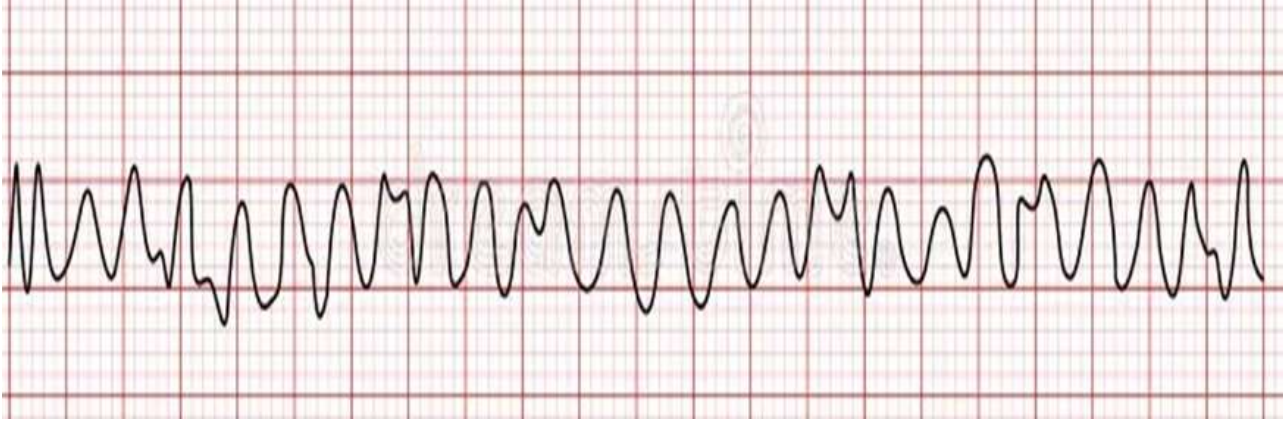


- A) Amiodarona 300 mg intravenoso (i.v.).
- B) Atropina i.v., hasta 3 mg.
- C) Perfusión i.v. de Lidocaína.
- D) Perfusión i.v. de Metoprolol.

147 El paciente no responde a la medicación, pierde la consciencia y deja de respirar. Si se considera que es una AESP (Actividad Eléctrica Sin Pulso), el tratamiento inicial sería:

- A) Desfibrilación precoz.
- B) Amiodarona 300 mg.
- C) Adrenalina 1mg i.v.
- D) Compresiones torácicas de alta calidad y Adrenalina 1 mg cada 1-5 min.

148 Tras comprobar el monitor, a los 2 min se objetiva el siguiente trazado. ¿Cuál sería la pauta de actuación?



- A) Compresiones torácicas de alta calidad y Adrenalina 1 mg cada 3-5 min.
- B) Adrenalina 1 mg i.v.
- C) Desfibrilación precoz.
- D) Amiodarona 300 mg.

149 Como tratamiento complementario al anterior, si el paciente continúa en parada cardio-respiratoria, es FALSO:

- A) Continuar con las compresiones de alta calidad.
- B) Minimizar las interrupciones en la RCP.
- C) Es necesario intubación traqueal del paciente.
- D) Aumentar el nivel de energía del desfibrilador.

150 El paciente hace REC (Recuperación Espontánea de Circulación). ¿Cuál de estas medidas es fundamental?

- A) Realizar valoración ABCDE.
- B) EKG.
- C) Angio-TAC de tórax.
- D) Radiología de tórax.

**SAS_MÉDICO/A DE FAMILIA EN
UNIDADES DE URGENCIA
HOSPITALARIA 2023 / TURNO
LIBRE / PRUEBA APLAZADA**

**CUESTIONARIO
RESERVA**

151 En relación con la exploración neurológica de un paciente en coma, señale la respuesta FALSA:

- A) La presencia de reflejo fotomotor y reflejo cilioespinal es indicativa de indemnidad troncoencefálica.
- B) La midriasis arreactiva unilateral sugiere herniación del uncus con afectación del III par craneal homolateral.
- C) Las pupilas mióticas puntiformes arreactivas sugieren lesiones protuberenciales.
- D) Los ROC (reflejos oculocefálicos) consisten en la desviación conjugada de la mirada hacia el lado de giro de la cabeza del paciente.

152 Para el cálculo de la fracción de excreción de potasio en una hiperpotasemia, ¿qué parámetro de los siguientes NO es necesario?

- A) Creatinina plasmática.
- B) Urea plasmática.
- C) Potasemia.
- D) Potasio urinario.

153 En ventilación mecánica no invasiva, a la diferencia entre la presión aplicada durante la inspiración y la aplicada durante la espiración, se le denomina:

- A) IPAP (Presión Positiva Inspiratoria).
- B) Presión espiratoria.
- C) Presión de soporte.
- D) CPAP.

INSTRUCCIONES PARA LAS PERSONAS OPOSITORAS:

Las personas opositoras están obligadas a colaborar en el correcto desarrollo del examen cumpliendo las siguientes instrucciones; en caso contrario nos veríamos obligados a pedirle que abandone el examen.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES QUE A CONTINUACIÓN LE DETALLAMOS SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS:

- ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con TELÉFONO MÓVIL (o cualquier otro dispositivo electrónico conectado a datos).
- En caso de que necesite algún dispositivo electrónico por tema médico o relacionado con medidas de seguridad en el ámbito de la violencia de género, informe de ello a su entrada en el aula, y le indicarán qué instrucciones específicas debe seguir.
- SI SE LE HUBIERA OLVIDADO DEJAR EL MÓVIL EN CASA O A UN ACOMPAÑANTE, TIENE QUE PONERLO EN CONOCIMIENTO Y ENTREGÁRSELO A LOS RESPONSABLES DEL AULA, QUE LO CUSTODIARÁN HASTA FINALIZAR SU PRUEBA:
- Para ello le entregarán un sobre con autopegado, en el que deberá escribir su DNI, nombre y apellidos, introducir el dispositivo apagado en el sobre, cerrarlo y dejarlo claramente visible en su mesa de examen para que, antes del inicio del reparto de los cuadernillos de examen, sea depositado por las personas de la organización en la mesa del responsable del aula.
- Finalizada la prueba, podrá recoger su móvil tras la presentación de su DNI.

SOBRE EL CORRECTO DESARROLLO DE LA PRUEBA:

- ENCIMA DE LA MESA DE EXAMEN SÓLO PUEDEN ESTAR su documento identificativo (DNI, pasaporte), el cuadernillo de examen y la hoja de respuesta que se le entreguen, el/ los bolígrafo/s y, en su caso, una botella de agua y caramelos. Los enseres personales, como bolsos, carteras, mochilas, etc., debe colocarlos en el suelo, a sus pies.
- ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PERSONAS OPOSITORAS Y ENTRE ÉSTAS Y EL EXTERIOR, ASÍ COMO EL USO Y TENENCIA DE DISPOSITIVOS MÓVILES.
- NO ESTÁ PERMITIDO LEVANTARSE DEL ASIENTO NI SALIR DEL AULA EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA HASTA EL MOMENTO EN QUE SE INICIE EL EJERCICIO. Después, podrá ir al baño, siempre acompañado por uno de los vigilantes del aula.

SOBRE EL CONTENIDO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN:

- Iniciada la prueba, si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, levante la mano y, cuando le atiendan, solicite su sustitución.
- Si entiende que existen preguntas confusas, incorrectamente formuladas o con respuestas erróneas, **LE RECORDAMOS QUE LA/S ALEGACIÓN/ES A LA/S PREGUNTA/S HA DE REALIZARSE A TRAVÉS DE LA V.E.C. EN LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN.**

NO ESTÁ PERMITIDO INTERRUPIR EL CORRECTO DESARROLLO DEL EXAMEN.

ANTE CUALQUIER CUESTIÓN O INCIDENCIA QUE TENGA, LEVANTE LA MANO Y ESPERE SENTADO/A Y EN SILENCIO A QUE LE ATIENDAN LAS PERSONAS QUE ESTÁN VIGILANDO EL DESARROLLO DE LA PRUEBA.

